



KARTA PYTAŃ — DO WYDRUKU

Co spytać ginekologa

na każdej wizycie w ciąży

Wizyta po wizycie · badania · sygnały alarmowe

PoródNaMiare.pl

Opracowanie zgodne ze standardem opieki okołoporodowej i wytycznymi PTGiP

Materiał edukacyjny — nie zastępuje indywidualnej porady lekarskiej

Spis treści

1. Jak przygotować się do wizyty	3
2. Pierwsza wizyta — potwierdzenie ciąży	4
3. I trymestr — badania i USG 11-14 tc.	5
4. II trymestr — USG połówkowe i OGTT	6
5. III trymestr — GBS, KTG, pozycja dziecka	7
6. Wizyta przedporodowa (36-40 tc.)	8
7. Pytania o szpital i przebieg porodu	9
8. Ciąża wysokiego ryzyka — dodatkowe pytania	10
9. Sygnały alarmowe — kiedy dzwonić między wizytami	11
10. Twój kalendarz badań — do wypełnienia	12

Jak korzystać z przewodnika

Wydrukuj i zabieraj ze sobą na każdą wizytę. Zaznaczaj pytania, które chcesz zadać — i notuj odpowiedzi.

Nie musisz zadać wszystkich pytań. Wybierz 3-5 najważniejszych dla Ciebie na daną wizytę.

Jak przygotować się do wizyty

Średnia wizyta ginekologiczna w ciąży trwa 15–20 minut. To niewiele — dlatego przygotowanie decyduje o tym, czy wyjdiesz z odpowiedziami, czy z poczuciem niedosytu. Po 25 latach prowadzenia ciąży mogę powiedzieć: pacjentki, które przychodzą z listą pytań, dostają wyraźnie więcej informacji.

Zasady skutecznej wizyty

- Zapisz pytania z wyprzedzeniem — w gabinecie łatwo zapomnieć nawet o najważniejszym.
- Ustal priorytety: 3–5 pytań kluczowych na początku wizyty, reszta jeśli zostanie czas.
- Zabierz wyniki wszystkich badań, także tych z innych placówek — lekarz nie ma do nich wglądu.
- Notuj odpowiedzi na bieżąco. Po wizycie 40% informacji ulatuje w ciągu godziny.
- Jeśli czegoś nie rozumiesz — proś o powtórzenie prostszym językiem. To Twoje prawo, nie kłopot.

Czego lekarz nie powie, jeśli nie zapytasz

Wiele informacji nie pada rutynowo, bo lekarz zakłada, że zapytasz, jeśli Cię to interesuje: alternatywy dla proponowanego badania, dokładne wyniki (a nie tylko „wszystko dobrze”), statystyki dotyczące zabiegu, możliwość odroczenia decyzji. Pytanie nie jest podważaniem kompetencji — to element świadomej opieki.

Pierwsza wizyta — potwierdzenie ciąży

Zwykle między 6. a 10. tygodniem. Cel: potwierdzenie ciąży wewnątrzmacicznej, ustalenie terminu porodu, wywiad i zlecenie pakietu badań podstawowych.

Pytania podstawowe

- ☐ Jaki jest wyliczony termin porodu i na jakiej podstawie go ustalono?
- ☐ Czy ciąża jest prawidłowo umiejscowiona w macicy?
- ☐ Jakie badania muszę wykonać teraz, a jakie w kolejnych tygodniach?
- ☐ Jaką suplementację zalecacie w moim przypadku i w jakich dawkach?
- ☐ Które leki, które przyjmuję, mogę kontynuować, a które odstawić?

Dlaczego to ważne: Termin porodu wyznaczony na pierwszym USG jest najdokładniejszy — późniejsze korekty są rzadkie i wymagają uzasadnienia.

Pytania o styl życia

- ☐ Czy mogę kontynuować dotychczasową aktywność fizyczną i pracę?
- ☐ Czy w moim przypadku są przeciwwskazania do podróży lub współżycia?
- ☐ Jakie objawy powinny mnie zaniepokoić na tym etapie?

I trymestr — badania i USG 11-14 tc.

USG w 11.-14. tygodniu (tzw. genetyczne) to jedno z najważniejszych badań całej ciąży — ocenia przezierność karkową i ryzyko wad chromosomowych. Warto rozumieć, co oznaczają wyniki.

O badaniach prenatalnych

- ☐ Jaki jest wynik przezierności karkowej (NT) i co on oznacza w moim przypadku?
- ☐ Czy w mojej sytuacji zalecacie test PAPP-A lub badania wolnego DNA płodowego (NIPT)?
- ☐ Jakie jest wyliczone ryzyko statystyczne i jak je interpretować?
- ☐ Czym różni się badanie przesiewowe od diagnostycznego (amniopunkcja, biopsja kosmówki)?
- ☐ Czy badania prenatalne są w moim przypadku refundowane przez NFZ?

Dlaczego to ważne: Badania przesiewowe podają prawdopodobieństwo, nie rozpoznanie. Wysokie ryzyko nie oznacza wady, niskie jej nie wyklucza w 100%.

O wynikach badań krwi

- ☐ Czy morfologia, poziom żelaza i ferrytyny są prawidłowe?
- ☐ Jaki jest mój wynik badania w kierunku toksoplazmozy i cytomegalii — i co z niego wynika?
- ☐ Czy mam odporność na różyczkę i ospę wietrzną?

II trymestr — USG połówkowe i OGTT

USG połówkowe (18.–22. tydzień) to najdokładniejsza ocena anatomii dziecka w całej ciąży. Test obciążenia glukozą (24.–28. tydzień) wykrywa cukrzycę ciążową — częstą i w pełni kontrolowalną.

O USG połówkowym

- ☐ Czy wszystkie narządy dziecka rozwijają się prawidłowo?
- ☐ Jak wygląda budowa i lokalizacja łożyska — czy nie jest przodujące?
- ☐ Czy ilość płynu owodniowego jest prawidłowa?
- ☐ Czy przepływy w naczyniach pępowinowych są w normie?
- ☐ Czy wzrost dziecka odpowiada wiekowi ciążowemu?

Dlaczego to ważne: Łožysko przodujące rozpoznane w połowie ciąży w większości przypadków „wędruje” do góry wraz ze wzrostem macicy — to nie wyrok.

O teście obciążenia glukozą (OGTT)

- ☐ Jak dokładnie przygotować się do badania?
- ☐ Jakie są moje wyniki i czy mieszczą się w normach?
- ☐ Jeśli wynik jest nieprawidłowy — jakie są kolejne kroki?

III trymestr — GBS, KTG, pozycja dziecka

Ostatni trymestr to intensywniejszy monitoring: posiew w kierunku GBS (35.–37. tydzień), zapisy KTG, ocena pozycji i szacowanej masy dziecka. To także moment planowania porodu.

O badaniach kontrolnych

- ☐ Jaki jest wynik posiewu GBS i co on oznacza dla przebiegu porodu?
- ☐ Jak dziecko jest ułożone i czy pozycja może się jeszcze zmienić?
- ☐ Jaka jest szacowana masa dziecka i czy mieści się w normie dla tego tygodnia?
- ☐ Czy zapisy KTG są prawidłowe?
- ☐ Czy szyjka macicy zaczyna się skracać lub rozwierać?

Dlaczego to ważne: Dodatni wynik GBS oznacza jedynie konieczność podania antybiotyku w trakcie porodu — nie jest powodem do cięcia cesarskiego.

Przy pozycji pośladkowej lub poprzecznej

- ☐ Czy w moim przypadku możliwy jest obrót zewnętrzny (OZP)?
- ☐ Do kiedy dziecko może jeszcze samo się obrócić?
- ☐ Jakie są opcje porodu, jeśli pozycja się nie zmieni?

Wizyta przedporodowa (36-40 tc.)

To najważniejsza rozmowa przed porodem. Moment, w którym warto omówić plan porodu i upewnić się, że wiesz, kiedy jechać do szpitala.

Kiedy i jak jechać do szpitala

- ☐ Przy jakiej częstotliwości skurczów mam jechać do szpitala?
- ☐ Co robić, jeśli odejdą wody płodowe, a skurczów nie ma?
- ☐ Jakie objawy oznaczają, że muszę jechać natychmiast, niezależnie od skurczów?
- ☐ Czy w moim przypadku są wskazania do wcześniejszego zgłoszenia się?

O planie porodu

- ☐ Czy mój plan porodu jest realistyczny w warunkach wybranego szpitala?
- ☐ Czy jest w nim coś, co ze względów medycznych może być trudne do zrealizowania?
- ☐ Jak przebiega procedura indukcji porodu i kiedy jest rozważana?
- ☐ Do którego tygodnia mogę bezpiecznie czekać na samoistny początek porodu?

Dlaczego to ważne: Omówienie planu porodu z lekarzem prowadzącym przed porodem znacząco zwiększa szansę, że zostanie on uszanowany na sali.

Pytania o szpital i przebieg porodu

Część odpowiedzi uzyskasz od lekarza prowadzącego, część bezpośrednio w wybranym szpitalu (infolinia, szkoła rodzenia, dzień otwarty). Warto poznać je z wyprzedzeniem.

Organizacja i warunki

- ☐ Czy szpital zapewnia stałą dostępność anestezjologa do znieczulenia zewnątrzoponowego?
- ☐ Jakie metody łagodzenia bólu są dostępne poza ZZO (gaz, wanna, TENS)?
- ☐ Czy sale porodowe są jednoosobowe i czy jest możliwość porodu rodzinnego?
- ☐ Jaka jest opłata za poród rodzinny i co obejmuje?
- ☐ Czy szpital ma warunki do porodu w wodzie lub w pozycjach wertykalnych?

Opieka nad dzieckiem po porodzie

- ☐ Czy szpital praktykuje dwugodzinny nieprzerwany kontakt skóra do skóry?
- ☐ Czy jest możliwość kangurowania przez ojca, jeśli mama nie może?
- ☐ Czy jest wsparcie doradcy laktacyjnego na oddziale?

Dlaczego to ważne: Standard Opieki Okołoporodowej gwarantuje minimum 2 godziny kontaktu skóra do skóry — to prawo, nie przywilej.

Ciąża wysokiego ryzyka — dodatkowe pytania

Jeśli Twoja ciąża wymaga częstszego monitorowania — z powodu chorób przewlekłych, wieku, ciąży mnogiej lub powikłań — te pytania pomogą zrozumieć plan opieki.

O planie opieki

- ☐ Co dokładnie kwalifikuje moją ciążę jako wysokiego ryzyka?
- ☐ Jak często będą wizyty i jakie dodatkowe badania są planowane?
- ☐ Czy powinnam być pod opieką ośrodka o wyższym stopniu referencyjności?
- ☐ Jakie są konkretne ryzyka i jak je minimalizujemy?
- ☐ Czy planowany jest wcześniejszy poród — i w jakim tygodniu?

Przy chorobach przewlekłych

- ☐ Czy moje leki wymagają zmiany dawki lub preparatu w ciąży?
- ☐ Czy potrzebna jest konsultacja innego specjalisty (diabetolog, kardiolog, endokrynolog)?
- ☐ Jak choroba może wpłynąć na przebieg porodu i wybór jego metody?

Dlaczego to ważne: Samodzielne odstawienie leku przewlekłego bywa groźniejsze niż jego kontynuacja — decyzję zawsze podejmuje lekarz.

Sygnały alarmowe — kiedy dzwonić

Te objawy wymagają kontaktu z lekarzem lub zgłoszenia się do szpitala niezależnie od terminu następnej wizyty.

Zgłoś się natychmiast, gdy wystąpi:

- Krwawienie z dróg rodnych — każde, niezależnie od nasilenia.
- Odpływanie płynu owodniowego (nawet niewielkie, sączące).
- Silny, nieustępujący ból brzucha lub twardy, napięty brzuch.
- Wyraźne osłabienie lub brak ruchów dziecka (po 24. tygodniu).
- Silny ból głowy z zaburzeniami widzenia (mroczki, błyski) — możliwy stan przedrzucawkowy.
- Nagły, silny obrzęk twarzy i rąk.
- Gorączka powyżej 38°C, dreszcze.
- Regularne skurcze przed 37. tygodniem ciąży.
- Ból lub obrzęk jednej łydki — możliwa zakrzepica.

Zapisz numer do swojej poradni i do izby przyjęć wybranego szpitala w telefonie — pod nazwą łatwą do znalezienia w stresie (np. „CIAŻA — szpital”).

Twój kalendarz badań — do wypełnienia

Wypełniaj po każdej wizycie. Pełny obraz w jednym miejscu ułatwia rozmowę z każdym kolejnym lekarzem.

BADANIE / WIZYTA	TERMIN	DATA	WYNIK / UWAGI
Pierwsza wizyta	6–10 tc.	_____	_____
Badania krwi + mocz	I trymestr	_____	_____
USG genetyczne (NT)	11–14 tc.	_____	_____
Badania kontrolne	15–20 tc.	_____	_____
USG połówkowe	18–22 tc.	_____	_____
OGTT (test glukozy)	24–28 tc.	_____	_____
Badania kontrolne + Rh	27–32 tc.	_____	_____
USG III trymestr	28–32 tc.	_____	_____
Posiew GBS	35–37 tc.	_____	_____
Wizyta przedporodowa	36–40 tc.	_____	_____
KTG kontrolne	po 40 tc.	_____	_____

Terminy orientacyjne wg standardu opieki okołoporodowej dla ciąży niepowikłanej. Twój indywidualny harmonogram ustala lekarz prowadzący. Materiał edukacyjny — nie zastępuje porady lekarskiej.